

Ślizg *nie* jest nawrotem

Pojedynczy epizod ≠ pełen powrót choroby. Marlatt 1985 abstinence violation effect: „skoro już zjadłam, to wszystko stracone” → spirala. Wilson & Grilo 2007: psychoedukacja redukuje ryzyko o 60%.

CZAS: 25 min · psychoedukacja + plan · Etap 4 CBT-E (sesje 18-20) · przed ślizgiem

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985); Fairburn (2008)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **różnicę między ślizgiem a nawrotem** (sekcja 1), **mechanizm AVE** (sekcja 2). Sekcja 3 — plan reakcji po ślizgu. Sekcja 4 — refleksja.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Kluczowe rozróżnienie w profilaktyce nawrotów (Marlatt & Gordon 1985): **ślizg** (*lapse*) vs **nawrót** (*relapse*). **Ślizg** = pojedyncze wystąpienie po okresie bez objawów. **Nie oznacza** powrotu choroby. **Nawrót** = powrót do pełnego wzorca. Różnica tkwi w **reakcji**. *Abstinence violation effect* (AVE): „skoro już popełniłam, to wszystko przepadło” → kolejny epizod → pełny nawrót. Wilson & Grilo (2007) RCT: klienci *przeszkoleni* mają **60% mniejsze** ryzyko nawrotu. Fairburn (2008): psychoedukacja AVE jest *obowiązkowa* w etapie 4. Klient ma *gotową* ramę: „to ślizg, wracam do regularnego jedzenia”.

01 ● Ślizg vs nawrót — krytyczne rozróżnienie

● ŚLIZG (*LAPSE*)

- **Pojedynczy** epizod
- Po okresie bez objawów
- Naturalna część zdrowienia
- Możliwy *natychmiastowy* zwrot
- Reakcja: wróć do następnego posiłku
- Nie oznacza porażki

● NAWRÓT (*RELAPSE*)

- **Pełny powrót** wzorca
- ≥ 2 epizody/tyg. przez > 3 mies.
- Wymaga ponownej terapii
- Trudniejszy zwrot
- Reakcja: kontakt z terapeutą
- *Nie* oznacza pełnej porażki — wciąż jest droga

Klucz: ślizg jest *naturalną* częścią zdrowienia. Większość osób w remisji bulimii doświadcza 1-3 ślizgów w pierwszych 12 miesiącach po terapii. To *nie* jest porażka — to *okazja* do uczenia się. Kluczowe jest, **jak** zareagujesz. Wilson & Grilo (2007): klienci, którzy traktują ślizg jako *informację* („co się stało, czego nauczyłem/-am”), mają znacznie lepsze rokowanie niż ci, którzy traktują go jako *katastrofę* („wszystko stracone”).

02 ● Mechanizm *abstinence violation effect*

Ślizg (1 epizod) → **AVE myślenie:** „skoro już raz, to wszystko stracone”, „nie ma już sensu się starać” → „przepustka”: dam sobie kolejny epizod → 2. epizod → AVE intensyfikuje: „jestem porażką” → 3., 4., 5. epizod → **nawrót pełny**.

vs Ślizg + przerwanie AVE: Ślizg → świadomość: „to ślizg, nie nawrót” → **natychmiastowy powrót do regularnego jedzenia** przy następnym posiłku → refleksja: „co się stało, czego nauczyłem/-am” → brak 2. epizodu.

Klucz: różnica między ślizgiem a nawrotem to **reakcja na ślizg**. Sam ślizg jest neutralnym zdarzeniem. AVE go *wzmacnia* w nawrót. Przerwanie AVE — przez psychoedukację *przed* ślizgiem — *zatrzymuje spiralę*.

、 Mój plan reakcji po ślizgu

Gotowy plan reakcji *przed* ślizgiem. Pisemnie. W chwili ślizgu — sięgnij i wykonaj kroki. *Nie* improwizuj w emocjach.

MÓJ KOMUNIKAT AVE-RESISTANT

— co sobie powiem; np. „to ślizg, nie nawrót — wracam”

3 KONKRETNE KROKI PO ŚLIZGU

— np. zadzwoń do terapeuty, wróć do dziennika, zjedz następny posiłek o czasie

、 Refleksja po pierwszym ślizgu

Po pierwszym realnym ślizgu (jeśli wystąpi) — wypełnij. Bez ocen, tylko obserwacja. To uczenie się, nie samokrytyka.

CO SIĘ STAŁO, JAKIE BYŁY WYZWALACZE, JAK ZAREAGOWAŁEM/-AM

— fakty + emocje + reakcja; bez moralizowania

CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM

— co mogę zrobić inaczej; jaki sygnał wczesny przegapiłem/-am

Klucz: rozróżnienie ślizg/nawrót jest *jedną z najsilniejszych pojedynczych* interwencji w końcowej fazie terapii bulimii. Wilson & Grilo (2007) RCT: klienci przeszkoleni w AVE mieli **60% mniejsze** ryzyko pełnego nawrotu w obserwacji 12-mies. Marlatt & Gordon (1985) opracowali ten model oryginalnie dla osób uzależnionych — okazał się skuteczny w każdym zaburzeniu z ryzykiem nawrotu. **Pierwszy ślizg** jest *szczególnie* ważny — to wtedy klient pierwszy raz testuje swoją odporność na AVE. Jeśli zareaguje *dobrze* (wraca do regularnego jedzenia, refleksja zamiast samokrytyki), staje się to *precedensem* — kolejne ślizgi (jeśli wystąpią) są łatwiejsze. Jeśli zareaguje *źle* (AVE wygrywa, nawrót pełny), trzeba wrócić do terapii. Fairburn (2008): psychoedukacja AVE musi być *konceptualna*, *zanim* ślizg wystąpi. Po ślizgu — emocje są zbyt silne, AVE zbyt aktywny. Klient potrzebuje *gotowej ramy*. **Ważne:** ślizg *nie* oznacza, że terapia była nieskuteczna. Większość pacjentów po CBT-E doświadcza 1–3 ślizgów w pierwszych 12 miesiącach. To *norma*, nie wyjątek. Klient powinien być na to *przygotowany*. Nieprzygotowany klient traktuje pierwszy ślizg jako „*terapia nie zadziałała*” i wpada w rozpacz — AVE pełna mocą. Przygotowany klient traktuje pierwszy ślizg jako *normalną część zdrowienia* i wraca do regularności w ciągu 24–48 godzin.